

Tenue vestimentaire au bloc opératoire

Méthodologie & tenue de bloc opératoire



Résumé : RPP commune SFAR-SF2H (avec validation AFC/CERES) sur la tenue vestimentaire au bloc opératoire : tenue de bloc, articles coiffants, masques, chaussures/sur-chaussures. Objectifs : prévention du risque infectieux pour le patient **et** réduction de l'impact environnemental (choix réutilisable/usage unique). **Ces RPP se substituent** aux recommandations SFAR et/ou SF2H précédentes sur ce champ.

Méthodologie

Méthodologie GRADE annoncée mais non intégralement applicable (la majorité des questions relève d'un avis d'expert plutôt que d'un niveau de preuve gradable) — formulation uniforme « les experts suggèrent de faire/de ne pas faire », cotation Delphi GRADE grid. *Note de comptage* : la source annonce « 13 recommandations », mais le compte direct des énoncés individuellement tagués « Avis d'expert (Accord Fort) » donne **16** — aucun regroupement évident par numéro parent ne réconcilie exactement ce chiffre avec 13. Divergence disclosed, non résolue ; cette fiche liste les 16 énoncés individuels dans l'ordre et la numérotation de la source.

AE

Format **RPP**, méthodologie GRADE partiellement applicable — formulation uniforme « les experts suggèrent » (avis d'expert). Toutes les recommandations de ce texte sont à **Accord fort** (100 % selon la source).

CHAMP 1 — Tenue de bloc opératoire (R1.1-R1.5)

N°	Recommandation	Accord
R1.1.1	Le personnel de bloc opératoire porte une tenue dédiée au bloc opératoire, indifféremment à usage unique ou réutilisable, pour prévenir le risque infectieux pour le patient.	AE
R1.1.2	Le personnel porte une tenue réutilisable plutôt qu'une tenue à usage unique, pour diminuer l'impact environnemental.	AE
N°	Recommandation	Accord
R1.2	Réaliser un essai sur le terrain des différents produits sélectionnés (efficacité, coût environnemental) auprès du personnel qui les utilisera, pour en apprécier les caractéristiques d'usage.	AE
N°	Recommandation	Accord
R1.3.1	En cas de souhait de se protéger du froid, le personnel porte par-dessus sa tenue une veste à manches longues, indifféremment à usage unique ou réutilisable.	AE
R1.3.2	Le personnel qui souhaite se protéger du froid n'utilise pas une casaque chirurgicale stérile dans cette indication (surcoût, risque de contamination de la tenue si la casaque traîne au sol).	AE
N°	Recommandation	Accord
R1.4.1	Le personnel ne quitte pas le bloc opératoire avec sa tenue de bloc, pour en limiter la contamination.	AE
R1.4.2	Si le personnel doit, à titre exceptionnel, répondre à un motif impérieux et quitter le bloc avec sa tenue, il en change à son retour.	AE
R1.4.3	En cas de sortie courte (quelques minutes), une alternative possible est de couvrir sa tenue de bloc par une blouse fermée.	AE
N°	Recommandation	Accord
R1.5	Le personnel change de tenue de bloc en cas de souillures, et au minimum à la fin de chaque journée de travail.	AE

Tenue vestimentaire au bloc opératoire

Articles coiffants, masques, chaussures & sources



CHAMP 2 — Articles coiffants (R2.1-R2.2)

N°	Recommandation	Accord
R2.1.1	Le personnel porte un article coiffant, indifféremment à usage unique ou réutilisable, lors de sa présence dans l'enceinte du bloc opératoire, pour prévenir le risque infectieux.	AE
R2.1.2	Le personnel porte un article coiffant réutilisable soumis à un entretien régulier plutôt qu'un article à usage unique, pour diminuer l'impact environnemental.	AE
N°	Recommandation	Accord
R2.2	Le personnel porte un article coiffant recouvrant toute la chevelure — indifféremment une charlotte, un calot ou une cagoule, aucun type n'ayant démontré de supériorité pour prévenir le risque infectieux.	AE

CHAMP 3 — Masques (R3.1-R3.2)

N°	Recommandation	Accord
R3.1	Le personnel non-chirurgical de bloc opératoire porte un masque à usage médical de type II ou IIR (norme NF EN 14683:2019) en salle d'intervention, pour diminuer le risque de transmission de micro-organismes à partir de l'oropharynx et du nez.	AE
N°	Recommandation	Accord
R3.2	Le personnel change de masque chirurgical quand celui-ci devient humide ou présente des traces de projections de liquides biologiques, pour diminuer le risque de transmission de micro-organismes.	AE

Repère : une étude (Zhiqing et al.) suggère une contamination significativement accrue du masque au-delà de 2 heures de port — pertinence clinique en termes d'infection du site opératoire non démontrée à ce jour ; en l'absence de notion de durée, changer le masque s'il est souillé ou humide reste la règle retenue (R3.2).

CHAMP 4 — Chaussures / sur-chaussures (R4.1-R4.2)

N°	Recommandation	Accord
R4.1	Pour réduire la contamination de l'environnement du bloc opératoire, le personnel porte des chaussures réservées exclusivement à l'enceinte du bloc (norme EN ISO 20347:2012), changées au minimum quotidiennement (et plus en cas de souillures visibles), lavées régulièrement en machine.	AE
R4.2	Le personnel ne porte pas de sur-chaussures en plus des chaussures dédiées — le port de sur-chaussures n'est pas plus efficace pour réduire la contamination de l'environnement, et s'accompagne d'un risque de contamination des mains.	AE

Sources et traçabilité

Document source : « Tenue vestimentaire au bloc opératoire » — RPP commune SFAR-SF2H, avec validation de l'Association Française de Chirurgie (AFC) et du Collectif EcoResponsabilité En Santé (CERES). Texte validé par le Comité des Référentiels Cliniques de la SFAR (05/05/2021), le CA de la SFAR (19/05/2021), le Conseil Scientifique de la SF2H (06/05/2021) et le CA de l'AFC/CERES (28/05/2021).

Méthodologie : GRADE partiellement applicable, formulation RPP (« les experts suggèrent »), cotation Delphi GRADE grid — voir détail en page 1.

URL source : <https://sfar.org/download/tenue-vestimentaire-au-bloc-operatoire/?wpdmdl=35399>

Couverture : intégralité des 16 énoncés gradés individuellement (4 champs thématiques : tenue de bloc, articles coiffants, masques, chaussures/sur-chaussures) — voir disclosure de la divergence de comptage source (13 annoncées vs 16 comptées) en page 1.

Avertissement — document validé 2021 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité des recommandations du texte source, mais ne le remplace pas et n'est ni éditée ni validée par la SFAR ou la SF2H. Se référer aux protocoles locaux d'hygiène du bloc opératoire et au texte intégral pour l'argumentaire bibliographique complet.